

 МедИнфа

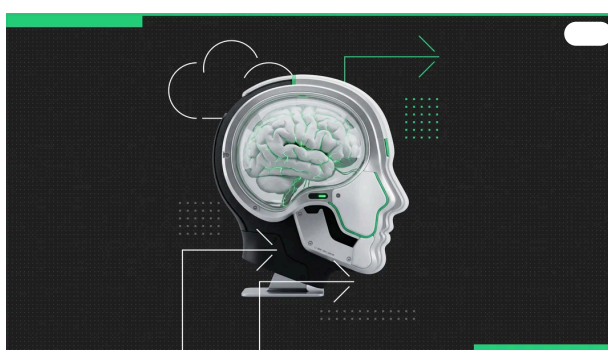
## Выбор оптимального препарата для терапии трихомониаза

29 января 2019  46  13,4 тыс.

Статью проверила Дарья Сергеевна Семенова   
терапевт, клиника Яндекс.Здоровье

*К м.н. А.А. Фадеев, профессор К.М. Ломоносов ММА имени И.М. Сеченова*

Возбудителем урогенитального трихомониаза является влагалищная трихомонада (*Trichomonas vaginalis*) – аэротолерантный анаэроб из отряда простейших, класса жгутиковых. Трихомонада – одноклеточный микроорганизм чаще грушевидной формы, на переднем конце тела которого расположены заключенные под внешней оболочкой 4 свободных жгутика; пятый жгутик образует край ундулирующей мембраны вдоль тела микроорганизма. За счет движений жгутиков трихомонада очень подвижна и пластична.



**ИИ на практике:  
создайте агента  
без кода**



cloud.ru РЕКЛАМА · 16+

Примечательна ее способность образовывать псевдоподии, маскирующие движения жгутиков и приводящие к

медленному амебевидному передвижению (амебоидная форма).

В такой форме трихомонады способны сливаться с



## У нас появились аптеки!

Теперь можно искать лекарства в разных аптеках, сравнивать цены и находить лучшие предложения в своем городе!

[Попробовать](#)

(уретропростатита) у мужчин и вульвовагинита и уретрита у женщин. Как правило, процесс изначально протекает в виде острой или подострой формы, затем через 2 месяца воспалительная реакция стихает и трихомониаз переходит в хроническую форму или трихомонадоносительство.

Клиническая картина мочеполового трихомониаза неспецифичная. Трихомонада способна поражать любые органы уrogenитального тракта, процесс может также локализоваться на слизистой [миндалины](#), конъюнктивы, прямой кишки. Следует отметить, что в виде моноинфекции трихомониаз встречается лишь у 10–30% пациентов, в 70–80% случаев уrogenитальный трихомониаз ассоциируется с другими микроорганизмами, в том числе и инфекциями, передаваемыми половым путем.

Чаще всего регистрируются трихомонадно–гонорейная, трихомонадно–бактериальная (в ассоциации с энтерококками, гемолитическими стрептококками, эпидермальным стафилококком), а также трихомонадно–микотическая инфекции. Важен тот факт, что при микст-инфекции трихомонада является резервуаром сопутствующей инфекции, поэтому вследствие внутритрихомонадной персистенции гонококки, хламидии и др. неуязвимы для антибиотиков, что приводит к рецидиву заболевания.

Клиническая картина уrogenитального трихомониаза не отличается от любой другой инфекции, передаваемой половым путем.

Вышеописанное делает диагностику трихомониаза особенно актуальной. Следует сразу оговориться, что **диагностика трихомониаза** у мужчин менее информативна, чем у женщин,

## У нас появились аптеки!

Теперь можно искать лекарства в разных аптеках, сравнивать цены и находить лучшие предложения в своем городе!

Попробовать

возможности, чтобы не рекомендовать их к использованию в повседневной практике.

Основной проблемой в диагностике трихомониаза является морфологическая вариабельность возбудителя.

Обнаружение типичных жгутиковых подвижных форм, как правило, не вызывает затруднений, однако неподвижные амёбевидные формы, сливающиеся с эпителиальными клетками, требуют от врача высочайшего профессионализма.

Терапия урогенитальных инфекций всегда остается актуальной и обсуждаемой проблемой дерматовенерологии, акушерства и гинекологии, урологии. В отношении трихомониаза основным предметом для дискуссий является терапия микст-инфекций, а так же выбор оптимального противопротозойного препарата. Поскольку за счет незавершенного фагоцитоза трихомонада зачастую является основной причиной неудач в терапии ИППП, при ассоциированных инфекциях необходимо в первую очередь проводить **пульс-терапию трихомониаза**.

Для этого существует большой арсенал быстродействующих и эффективных антипротозойных средств. Все рекомендуемые препараты относятся к группе нитроимидазола. Родоначальником (впрочем, не потерявшим свою значимость и по сей день) является [метронидазол](#). По данным Всемирной Организации Здравоохранения (2001 г.), однократный прием 2,0 г этого препарата приводит к излечению у 88% женщин, а при

совместном лечении половых партнеров положительный эффект достигается в 95% случаев. Такая же высокая эффективность и у [тинидазола](#).

## У нас появились аптеки!

Теперь можно искать лекарства в разных аптеках, сравнивать цены и находить лучшие предложения в своем городе!

[Попробовать](#)

достоверно определить сроки инфицирования, довольно проблемно исключить и поражение трихомонадами парауретральных желез, простаты и т.д. В связи с этим мы рекомендуем использовать вышеназванные препараты пролонгированными курсами по 5–10 дней. Для курсового системного лечения могут быть использованы и другие препараты группы нитроимидазола: ниморазол и нифурател.

В последние годы в России появляется все большее количество методически рекомендаций, указаний, стандартов по терапии ИППП. Все они основаны на большом клиническом материале, а выпускают их ведущие дерматовенерологические учреждения, Ассоциация акушеров–гинекологов. Существуют так же международные европейские рекомендации, рекомендации ВОЗ. Все они построены по единому принципу и предлагают как рекомендуемые схемы терапии, так и альтернативные.

По данным ВОЗ, **рекомендуемыми являются схемы терапии трихомониаза [метронидазолом](#) или [тинидазолом](#) в однократной дозировке 2,0 г**. Альтернативным является применение тех же препаратов по 500 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней. Сходные данные представляют специалисты США, выводя [метронидазол](#) на первое место – 2,0 г однократно.

Согласно данным европейских рекомендаций оптимальным способом лечения трихомониаза является прием [метронидазола](#) в течение 7 дней по 500 мг каждые 8 часов.

В отечественных «Методических материалах по диагностике и лечению наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем, и заболеваний кожи»,

## У нас появились аптеки!

Теперь можно искать лекарства в разных аптеках, сравнивать цены и находить лучшие предложения в своем городе!

[Попробовать](#)

каждые 12 часов в течение 5 дней, [метронидазол](#) по 500 мг 2 раза в сутки (7 дней), а также ниморазол, секнидазол и нифурател в стандартных дозировках.

Итак, как же выбрать оптимальный антипротозойный препарат? По международному опыту, а также данным части отечественных исследователей – это [метронидазол](#).

Однако не все так однозначно. Что касается эффективности при соблюдении рекомендаций врача и одновременном лечении половых партнеров, то она примерно одинакова у всех препаратов (все производные нитроимидазола). В удобстве применения так же все препараты схожи, но что касается побочных эффектов, то, по собственным данным и данным литературы, все-таки переносимость [орнидазола](#) и [секнидазола](#) несколько лучше, чем у [метронидазола](#).

При приеме последнего чаще отмечаются диспептические расстройства, головные боли, бессонница, аллергические реакции, чем у других препаратов данной группы.

 46

[Пожаловаться](#) 

## У нас появились аптеки!

Теперь можно искать лекарства в разных аптеках, сравнивать цены и находить лучшие предложения в своем городе!

[Попробовать](#)



РЕКЛАМА